Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Charqueadas

Travessa Juca Buchaim, 121 - Bairro: Centro - CEP: 96745000 - Fone: (51) 3098-5391 - balcão virtual 51 - 99980 1966 - Email: frcharquea2vciv@tjrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5002100-92.2023.8.21.0156/RS

REQUERENTE: JULIO CESAR DA SILVA PINHEIRO
REQUERIDO: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

JULIO CESAR DA SILVA PINHEIRO ajuizou *ação de obrigação de fazer* em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA**, todos qualificados, alegando, em suma, ser filiado ao plano de saúde do réu. Afirmou ser portador de a LLA – leucemia linfoblástica aguda, desde 2021, e estava internado há 70 (setenta) dias, e teve a indicação do fornecimendo do medicamento ICLUSIG (PONATINIB), para controle da doença, sem o qual aumentaria seu risco de óbito, conforme atestado pela sua médica. Mencionou ter solicitado o medicamento administrativa, mas que foi negado sob o argumento de que o medicamento não possui cobertura obrigatória conforme rol da ANS. Afirmou que não possui condições financeiras de custear o tratamento. Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para determinar que a ré fornecesse o medicamento gratuitamente e, no mérito, a confirmação da tutela. Requereu gratuidade da justiça e juntou documentos (evento 1, INIC1).

Após emenda à inicial com a comprovação dos documentos de renda, restou deferida a gratuidade da justiça à parte autora. Ainda, deferida a tutela de urgência, a fim de determinar que a ré fornecesse/autorizasse o tratamento com o medicamento postulado (evento 8, DESPADEC1).

Na petição do evento 12, PET1, a demandada informou o cumprimento da liminar.

Citada, a ré contestou o feito (evento 14, CONT1). Inicialmente, afirmou ter cumprido a liminar. Preliminarmente, impugnou o valor atribuído à causa. No mérito, alegou que o fármaco não possui cobertura pelo plano de saúde contratado, bem como teceu acerca da taxatividade do rol de procedimentos publicados pela ANS. Requereu, assim, a improcedência do feito. Juntou documentos.

Houve réplica (evento 17, RÉPLICA1).

Em despacho saneador, restou inimada a parte autora para informar, mediante a juntada de orçamento, o custo mensal da medicação pretendida, adequando valor da causa. Ainda, intimadas as partes acerca das provas a serem produzidas no feito (evento 19, DESPADEC1).

A parte autora acostou aos autos orçamento atualizado do fármaco, afirmando estar correto o valor atribuído à causa (evento 25, PET1)

Nada mais sendo requerido pelas partes, o feito veio concluso para julgamento.

É o relato. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O processo transcorreu regularmente, não restando quaisquer eivas ou nulidades.

2.1. Da impugnação do valor da causa

A parte demandada, em contestação (evento 14, CONT1), impugnou o valor atribuído à causa, alegando, em suma, que deve ser fixado em conformidade com o art. 292, II, do CPC.

Na inicial, a parte autora atribuiu provisoriamente à causa o valor de R$ 26.400,00, correspondente ao valor pretendido a título de danos morais, na ausência de orçamentos dos custos da medicação. Em réplica (evento 17, RÉPLICA1), a parte autora sustentou que o valor da causa deve corresponder a uma prestação anual, estimada em R$ 795.000,00 (R$ 45.000,00, 15 cp, 2 cp ao dia), conforme art. 292, §2º, do CPC.

Assiste razão à parte autora, no sentido de que o valor da causa deve corresponder a uma prestação anual, considerando que não há prazo para o término do tratamento, consoante art. 292, § 2º, do CPC, *in verbis*:

> *Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º O valor das prestações vincendas será*
>
> *igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.*

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do TJ/RS:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DEMANDA RELATIVA À COBERTURA DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA QUE CORRESPONDE A UM ANO DO TRATAMENTO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1) O juiz pode, mesmo de ofício, nos termos do § 3º do art. 292 do CPC, corrigir esse valor quando "verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão". ***Possuindo o medicamento valor certo, para utilização por tempo indeterminado, o valor da causa deve corresponder a uma prestação anual.*** *2) Possibilidade de arbitramento de honorários por equidade, na forma prevista no § 8º do art. 85 do CPC, quando inestimável o valor da cobertura indevidamente negada, observada a tese fixada no Tema 1076 STJ. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50104884520208210008, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 25-05-2023)*

Assim, o valor da causa deve corresponder a uma prestação anual, acrescido do valor pretendido a título de danos morais, conforme art. 292, §2º e art. 292, VI, do CPC.

Assim, considerando que o custo com tratamento anual é de R$ 274.703,76, e a indenização por danos morais pretendida é no valor de R$ 26.400,00, o valor da causa é R$ 301.103,76.

Assim, rejeito a impugnação ao valor da causa apresentada pela parte ré, devendo o valor da causa ser aquele apresentado pela autora no Evento 25 e já retificado pela unidade judiciária.

2.2. Do mérito

Trata-se de ação que almeja a parte autora seja determinado ao réu o cumprimento de obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento ICLUSIG (Ponatinib) 15mg, conforme orientação médica, sendo necessárias 2 (duas) caixas mensais para o correto enfrentamento de LLA – leucemia linfoblástica aguda.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Aliás, este é o entendimento da Súmula 608 do STJ.

Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso em análise, resta incontroversa a contratação do plano de saúde (evento 14, CONTR9) bem como o diagnóstico de LLA e a recomendação médica para uso do medicamento Pontinib (Iclusig) 15 mg - 2 comprimidos ao dia (evento 1, ATESTMED4).

De outro viés, a alegação da parte ré é de que o referido medicamento estaria excluído de cobertura para os tratamentos não elencados no rol de procedimentos da ANS.

No entanto, descabe a negativa. Isso porque o tratamento foi recomendado pela médica assistente da parte autora (evento 1, ATESTMED4), indicando que esta deve fazer uso contínuo de doses de Ponatinib (Iclusig) 15mg - 2 comprimidos ao dia, para controle da doença.

das mutações do ABL1, e melhor chance de benefício nesses pacientes. O uso de ponatinib, em associação com quimioterapia, demonstrou resposta molecular e sobrevida livre de eventos em 2 anos de 78%, e sobrevida geral de 80% em dois anos.

Não há tratamentos alternativos com chances de resposta aceitáveis neste caso. O tratamento deve ser mantido por tempo indeterminado, sob risco de recidiva, caso interrompa o tratamento. A dose a ser administrada segue abaixo:

- Ponatinib 15mg - tomar dois comprimidos por via oral, contínuo.

À disposição para maiores esclarecimentos,

Elisa Schneider
Hematologia
CRM-30113

Elisa Schneider - CRM/RS 30113
Hematologia

Porto Alegre, 09 de maio de 2023.

Assim, considerando a indicação médica, necessária se mostra a cobertura do tratamento da patologia coberta pelo plano.

Outrossim, além do princípio da boa-fé entre as partes, o plano ou seguro de saúde não pode, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem.

A propósito, um dos elementos essenciais do contrato de prestação de serviços médicos é a boa-fé entre os contratantes, prevista no art. 422 do Código Civil.

Além disso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado.

Nessa linha, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDE E MUTAÇÃO DO FATOR V DA PROTROMBINA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO ENOXAPARINA. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO. 4. RESSALTE-SE, OUTROSSIM, QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS PLANOS DE SAÚDE ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO. 5. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, HAVENDO LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR COM O MEDICAMENTO POSTULADO NA EXORDIAL (ENOXAPARINA), TEM-SE COMO DEVIDO O FORNECIMENTO DA ALUDIDA MEDICAÇÃO, SENDO IRRELEVANTE, NO CASO, O LOCAL ONDE SERÁ MINISTRADO O FÁRMACO. 6. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50019545120218210017, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 25-05-2022)

No mais, acerca da alegação defensiva da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, faço os seguintes esclarecimentos.

No que respeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, mister observar o disposto no artigo 4º, que, ao estabelecer a Política Nacional das Relações de Consumo e os princípios que devem ser observados, prioriza a proteção dos interesses econômicos e a transparência e harmonia das relações de consumo – entre consumidores e fornecedores.

Logo, considerando o disposto na própria Lei consumerista, a qual se aplica apenas de forma subsidiária à Lei Especial, conforme previsão do artigo 35-G da Lei dos Planos de Saúde (EAREsp 988.070/SP), a transparência e a harmonia da relação, que deve ser interpretada como aquilo que foi previamente acordado entre as partes, deve prevalecer.

Sendo assim, nas ações como a presente devem ser observadas as coberturas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual não pode prever aquelas excetuadas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e, também, não pode excluir ou mitigar as hipóteses do artigo 12 do mesmo diploma legal.

In verbis:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

III - inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

*VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (Redação dada pela **Lei** nº 12.880, de 2013) (Vigência)*

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a pesquisa, o tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar; (Vide Medida Provisória nº 1.685-5, de 1998) (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.

§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

Colhe-se, portanto, ser lícito que a cobertura contratual excetue o fornecimento de tratamento para determinada patologia quando não previsto em norma regulamentadora da ANS.

Cabível referir que, muito embora a decisão proferida pelo STJ, acerca da taxatividade do rol da ANS, por ocasião ao REsp nº 1733013/PR, em 21-9-2022, foi publicada a Lei n. 14.545/2022, que dispôs sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

A partir disso, sancionada a referida lei em 21-9-2022, que entrou em vigor na data da publicação, remanescem apenas duas das quatro condicionantes fixadas pelo STJ, em relação aos tratamentos e exames fora do rol da ANS, constantes nos itens "ii" e "iii", quais sejam: (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros.

Desse modo, sendo a Lei n. 14.545/2022 aplicável ao caso concreto, é com base nos parâmetros por ela definidos que passo à análise da pretensão da inicial.

No que respeita ao medicamento em questão - Ponatinib (Iclusig) -, embora este não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a partir de sua bula, é possível aferir que apresenta indicação para o tratamento de pacientes com leucemia - moléstia da autora -, por se tratar de fármaco antineoplásico, situação que afasta a alegação recursal de ausência de cobertura para medicamentos domiciliares, tendo em vista à exceção prevista no artigo 12, inciso I, alínea 'c', da Lei nº 9.656/1998.

Outrossim, além de ter indicação em bula para o tratamento da doença da autora, o fármaco postulado é um medicamento com registro sanitário na Anvisa sob o número 139000001, com recomendação de uso baseada em evidências científicas de sua eficácia, situação que, a toda a evidência, permite excetuar o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, consoante possibilita a Lei nº 14.454.

Afora isso, em consulta ao Sistema E-NATJUS[1] - ferramenta lançada para auxiliar na solução das controvérsias, como apoio ao judiciário, pelo CNJ e o Ministério da Saúde -, foi possível aferir a existência de Notas Técnicas favoráveis ao tratamento da doença que acomete o autor.

Destarte, devida a cobertura do tratamento pela ré.

Dos danos morais

Por fim, em relação aos danos morais, embora a negativa de cobertura por plano de saúde possa caracterizá-los, a questão deve ser examinada caso a caso.

Nessa linha, entendo cabível a reparação pretendida, uma vez que a hipótese dos autos reflete o dano moral *in re ipsa* ou dano moral puro, tendo em vista que a angústia, o sofrimento e o transtorno causados pela parte autora - portadora de leucemia linfoblástica aguda e internada há mais de 70 (setenta) dias - são presumidos, atingindo a autora e sua família em momento de induvidoso abalo psicológico, em razão da doença que a atingia e da necessidade urgente de início do tratamento, o que confere o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano.

Inclusive, foi necessário o ajuizamento da presente demanda para que a requerida autorizasse a realização do tratamento, sendo deferida a tutela de urgência (evento 8, DESPADEC1).

Sobre o tema, posiciona-se a jurisprudência do egrégio STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES MÉDICOS. TRATAMENTO DE CÂNCER. IDOSO. FALECIMENTO DO SEGURADO. DANO MORAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA. N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. ***1. É passível de danos morais a injusta recusa de cobertura de seguro saúde, por gerar situação de aflição psicológica e de angústia ao segurado que se encontra com a saúde debilitada. Precedente: REsp n. 918.392/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI.*** *2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor arbitrado pelo Tribunal de origem não se distancia dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 204.037/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 03/04/2013) (grifei).*

Também nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVER DE COBERTURA. MATERIAL LIGADO AO ATO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. ***2. Caso, no entanto, em que a negativa de cobertura extrapolou o mero dissabor, sendo necessária a cobertura do material ligado ao ato cirúrgico prescrito em regime de urgência / emergência. Realização do procedimento cirúrgico somente após o deferimento de medida antecipatória.*** *3. Valor indenizatório fixado em R$10.000,00, em observância às peculiaridades do caso e com o fim de assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem constituir-se elevado bastante para o enriquecimento indevido da parte autora. 4. Honorários advocatícios mantidos na forma da sentença. Peculiaridades do caso concreto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084873546, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 31-03-2021);*

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESOLUÇÃO DA ANS. COBERTURA DEVIDA. PAGAMENTO AO HOSPITAL. REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELA AUTORA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 2. Aplicáveis ao caso em exame as exigências mínimas previstas no plano-referência de que trata os artigos 10 e 12 da legislação dos planos de saúde. 3. O rol de procedimentos publicado pela ANS constitui apenas uma referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde. Ainda, as diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS servem como orientação, não sendo taxativas, de modo que deve ser observada a prescrição do médico assistente da parte autora. Precedentes desta Corte e do STJ. 4. No caso em tela não cabe à demandada determinar o tipo de tratamento que será realizado pela parte autora, uma vez que esta decisão é atribuição do médico que a acompanha. Ainda, restou comprovada a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pelo método postulado pelo médico assistente, não sendo indicada a sua realização pelo método tradicional, considerando o quadro de saúde específico da paciente, nos termos dos laudos acostados ao feito. 5. Assim, descabida a negativa securitária por parte da

demandada, pois o que importa para solução do litígio é a existência de cobertura para a patologia apresentada pela contratante, devendo ser mantida a sentença quanto à condenação da seguradora ré ao pagamento do montante principal devido ao Hospital. 6. Os juros moratórios são devidos a partir da citação, quando da constituição da mora, ex vi dos artigos 397, parágrafo único, do Código Civil e 240 do novel Código de Processo Civil. 7. Correção monetária que incide a partir do processamento do boleto, pois não representa encargo, uma vez que neutraliza os efeitos do tempo sobre o valor da moeda, ou seja, é consequência do próprio crédito, não importando em acréscimo ao quantum devido, mas mera manutenção do poder aquisitivo da moeda em curso no país, de sorte que a não-satisfação desta importa em enriquecimento sem causa por parte da apelante. 8. Reconhecido o dever de cobertura do procedimento realizado, deve a ré reembolsar os valores correspondentes ao tratamento e adiantados pela parte autora, conforme comprovantes acostados com a inicial, sendo limitado, contudo, ao montante de R$ 27.510,00 apresentado administrativamente para a ré a título de reembolso, conforme demonstrativo de reembolso juntado pela autora à fl. 117, acrescidos de juros da citação e correção monetária a contar de cada desembolso. 9. Ademais, conforme informado à fl. 119 dos autos, houve o reembolso parcial das despesas médicas de forma administrativa no valor de R$ 3.387,90, devendo ser abatido do valor acima mencionado, totalizando a quantia de R$ 24.122,10. 10. O descumprimento do contrato, sem razão jurídica plausível, ou mesmo o atendimento do pacto de forma negligente, sequer atentando para a garantia dada e o bem a ser preservado, importa no dever de reparar o mal causado. 11. ***A demandada deve ressarcir os danos morais reconhecidos, na forma do art. 186 do novo código civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, a qual se configurou no caso em tela. Quantum fixado em R$ 10.000,00, acrescido de juros moratórios da citação e correção monetária do arbitramento.*** *Dado parcial provimento aos recursos.(Apelação Cível, Nº 70084885854, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 31-03-2021);*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. MEDICAMENTO E INSUMOS. DEVER DE COBERTURA RECONHECIDA. DANOS MORAIS OCORRENTES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o ressarcimento despendido com medicamentos e insumos em razão de ter sido submetida ao procedimento cirúrgico – "Peritonectomia associada à aplicação de quimioterapia intra peritonial hipertérmica com a combinação de antineoplásticos cisplatina e mitomicina", em como indenização a título de danos morais, julgada parcialmente procedente na origem. COBERTURA SECURITÁRIA - É inocultável a incidência e regulação do Código de Defesa do Consumidor, em vista de que se trata de típico contrato de adesão, sendo manifesta a fragilização do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte do aderente, utente do crédito e, nessa condição, inferiorizado contratualmente. No caso telado, postula a parte autora a condenação da demandada ao custeio das despesas do tratamento de que necessita para tratar carcinoma (medicamentos e insumos). Pugna, ainda, pela condenação da ré a lhe indenizar pelos danos morais e materiais. Assim, uma vez constatada a necessidade e efetiva utilização do medicamento em questão solicitado pelo médico que atende a parte autora (fls. 123/124), haja vista sua grave situação de saúde, sendo portadora da Doença " Pseudomixonia Periotoneal" (CID C.48.2) tenho que não há justificativa para a negativa apresentada. Ademais, destaca-se que o contrato prevê cobertura para a patologia que acomete a parte autora, bem como, o tratamento, negando a parte ré a cobertura tão-somente porque o medicamento em questão não está no rol dos medicamentos de cobertura obrigatória, conforme Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS. Mostra-se descabida e abusiva a negativa de cobertura securitária, pois o que deve preponderar é o fato de que há previsão de cobertura para a enfermidade e, inclusive, para o tratamento prescrito ao autor, cabendo ao profissional da saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento. ***DANOS MORAIS - A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária não enseja reparação a título de dano moral.*** *DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA, POR MAIORIA E APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA, UNANIME.(Apelação Cível, Nº 70083603159, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 07-08-2020).*

Relativamente ao valor da indenização, adoto como parâmetros: as decisões jurisprudenciais emanadas em processos semelhantes; a capacidade econômica de quem deve indenizar, visando a alcançar o necessário elemento repressivo e pedagógico da condenação, e; a extensão do dano sofrido pela vítima, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Portanto, com base nestes parâmetros e atenta aos precedentes análogos, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, e dos juros moratórios, a contar da citação, pois se trata de relação contratual.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e, para os fins do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **PROCEDENTE** a ação de obrigação de fazer ajuizada por **JULIO CESAR DA SILVA PINHEIRO** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA** para:

3.1. confirmando a antecipação de tutela já deferida, **CONDENAR** a parte ré no fornecimento da medicação ICLUSIG (Ponatinib) 15mg conforme orientação médica, sendo necessárias 2 (duas) caixas mensais, para o correto enfrentamento da doença de que a parte autora é portadora;

3.2. CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$10.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, e dos juros moratórios, a contar da citação, pois se trata de relação contratual

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Em face da sistemática do Código de Processo Civil, notadamente no que tange à inexistência de admissibilidade no juízo *a quo* (art. 1.010, § 3º, do CPC), em caso de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Registra-se que, conforme o que prevê o item 6, "b", do Ofício-Circular n.º 77/2019-CGJ, eventual cumprimento de sentença deverá ser instaurado sob novo número.

Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, baixem-se os autos.

Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL FOLADOR, Juiz de Direito**, em 11/12/2023, às 18:42:4, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10050471907v16** e o código CRC **977af6ae**.

1. pesquisa disponível em https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php ↩